心悸

知识类别：症状与就医指引
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/heart-and-blood-vessel-disorders/symptoms-of-heart-and-blood-vessel-disorders/palpitations
获取日期：2026-10-17

以下为逐字转载的原文内容：

心悸
病因 |
评估 |
治疗 |
老年人须知 |
关键点 |
多媒体 |
心悸是指病人能感知到自己的心跳。感觉可能像重击、快速扑动、赛跑，或悄悄地跳动。根据心悸的病因，可能存在其他症状，例如 胸部不适 或 气短 。
心悸是常见的。某些人只是对心悸感到不悦和担忧，但很少成为威胁生命的心脏病的指征。许多没有心脏疾病的人同样也会出现心悸。
心悸的病因
一般来说，人们不会注意到自己的心跳。然而，在某些原因导致心跳较平时更有力或更快时，许多人会感觉到自己的心跳。这种快速、有力的跳动通常是心脏的正常反应（窦性心动过速）。原因包括：
锻炼
锻炼
剧烈情绪波动（例如焦虑、恐惧或疼痛）
剧烈情绪波动（例如焦虑、恐惧或疼痛）
低血细胞计数（ 贫血 ）
低血细胞计数（ 贫血 ）
低血压
低血压
发热
发热
脱水
脱水
在其他一些情况下，心脏节律紊乱（心律失常）可导致心悸。
心律失常类型
心律失常 的严重程度不等，从无害的到危及生命的都有。
最常见的心律失常 包括
房性早搏
房性早搏
室性早搏
室性早搏

这两种心律失常通常发生在没有心脏疾病人们身上并且无害。早搏本身感觉不到。所感觉到的是早搏之后的正常心跳，由于早搏而发生了轻微延迟且比平常略强。尽管人们觉得好像是心脏漏跳了一拍，但实际上并没有。
引起心悸和可能由严重心脏疾病引起的 其他心律失常 包括
阵发性室上性心动过速（PSVT）
阵发性室上性心动过速（PSVT）
心房颤动 或 心房扑动
心房颤动 或 心房扑动
室性心动过速
室性心动过速
这些心律失常导致心跳比正常情况下快很多。在心律失常中，心跳过缓很少会引起心悸，虽然有些人确实可感觉到心跳缓慢。
心律失常的病因
有些心律失常（如房性早搏，室性早搏，或 PSVT）往往发生在没有严重的基础疾病的人群中。其他心律失常往往是由严重的心脏疾病或是机体其他部位疾病导致。
严重的心脏疾病 包括 心绞痛 、 心脏病发作 （急性冠脉综合征）、先天性心脏疾病（例如，布鲁加达综合征或先天性 长 QT 综合征 ）、 心脏瓣膜病 和心脏传导系统紊乱（例如， 沃-帕-怀综合征 ）。
与心脏无关 、可能导致心律失常的疾病包括
甲状腺过度活跃（ 甲状腺功能亢进症 ）
甲状腺过度活跃（ 甲状腺功能亢进症 ）
低氧血症（缺氧）
低氧血症（缺氧）
血钾水平低（ 低钾血症 ）
血钾水平低（ 低钾血症 ）
血镁水平低（ 低镁血症 ）
血镁水平低（ 低镁血症 ）
某些治疗性药物、非法药物或物质，包括酒精、 咖啡因 、地高辛、 尼古丁 和一些兴奋剂药物（如沙丁胺醇、安非他明、 可卡因 、肾上腺素、麻黄碱和茶碱）
某些治疗性药物、非法药物或物质，包括酒精、 咖啡因 、地高辛、 尼古丁 和一些兴奋剂药物（如沙丁胺醇、安非他明、 可卡因 、肾上腺素、麻黄碱和茶碱）
肾上腺肿瘤（ 嗜铬细胞瘤 ）引起的激素水平升高
肾上腺肿瘤（ 嗜铬细胞瘤 ）引起的激素水平升高
并发症
引起心跳过快的心律失常可引起并发症（尤其是老年人）。如果心跳过快造成心脏泵血不足，会使人感觉头晕或晕倒，或者发生 心力衰竭 。尽管心率过快或心率长时间太快可以引起心衰，但是心衰主要见于既往发生过心衰或者有心脏病发作病史的人。心率加快也会增加心肌的耗氧量。心肌动脉狭窄（ 冠状动脉疾病 ）的患者会出现心绞痛或心脏病发作（可能致命）引起的胸痛。
某些心律失常，尤其是室性心动过速，是不稳定的，可直接导致 心脏骤停 。
心悸的评估
虽然心悸并非都是由心脏疾病引起的，但由于有些心脏疾病引发的后果非常严重，因而心悸的患者通常应该由医生进行评估。以下信息能帮助人们决定何时就医，并帮助他们了解评估中的期待。
警示体征
患有心悸的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括

头晕或昏厥
头晕或昏厥
胸痛或胸闷
胸痛或胸闷
气短
气短
脉率超过每分钟 120 次或每分钟少于 45 次
脉率超过每分钟 120 次或每分钟少于 45 次
具有心脏病或有猝死家族史、反复发作的昏厥，或不明原因的癫痫症
具有心脏病或有猝死家族史、反复发作的昏厥，或不明原因的癫痫症
运动中出现的症状，特别是如果它们引起意识丧失
运动中出现的症状，特别是如果它们引起意识丧失
何时就医
有心悸和任何警示征象者应该马上去看急诊。发生昏厥、胸痛或呼吸急促者应拨打急救电话。
无警示征象，偶发或曾经发生过心悸者应向医生电话咨询。医生将根据患者的年龄、基础状况和其他症状决定需要何时来就诊。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，可以帮助医生判断病因。
医生问诊
心悸多久会出现一次
心悸多久会出现一次
心悸会持续多长时间
心悸会持续多长时间
什么因素会引发或加重心悸（如情绪困扰、活动，或摄入 咖啡因 或其他药物）
什么因素会引发或加重心悸（如情绪困扰、活动，或摄入 咖啡因 或其他药物）
患者正在使用什么药物或物质，包括 咖啡因
患者正在使用什么药物或物质，包括 咖啡因
有时医生会让患者敲出发生心悸时心跳的速度和节奏，因为其节奏模式可以帮助医生确定心悸的原因。
身体检查从医生检查生命体征开始（脉搏、体温和血压）。脉率及脉搏跳动是否规整可帮助医生推测原因。体温升高可提示发热是心悸的病因。极低的血压虽不能提示心悸出现的病因，却表明病情极度紧急。
心脏异常听诊音可提示是否有心脏瓣膜病或心脏炎症。肺部听诊音可提示是否有心衰。医生通过观察和触诊可判断甲状腺有无肿大和炎症。
当心悸同时伴有其他症状（如呼吸急促、胸痛、无力、疲劳或者昏厥）时，很有可能是由异常心脏节律和某种严重疾病所致。
心悸的某些病因和特征
心悸的某些病因和特征
特征*
特征*
可能的原因
可能的原因
感觉心跳偶尔跳过几拍

感觉心跳偶尔跳过几拍
房性早搏 或 室性早搏
房性早搏 或 室性早搏
心跳突然加快然后突然转慢到正常速度
心跳突然加快然后突然转慢到正常速度
阵发性室上性心动过速 或 沃-帕-怀综合征 有时为 室性心动过速 或先天性 长 QT 综合征
阵发性室上性心动过速 或 沃-帕-怀综合征
有时为 室性心动过速 或先天性 长 QT 综合征
感觉到持续的快速、不规则心跳
感觉到持续的快速、不规则心跳
心房颤动
心房颤动
心悸时出现晕厥
心悸时出现晕厥
室性心动过速、遗传性心肌病（包括 肥厚型心肌病 和 致心律失常性右心室心肌病 ）、房颤、 心脏通道病 （包括 长 QT 综合征 和 Brugada 综合征）
室性心动过速、遗传性心肌病（包括 肥厚型心肌病 和 致心律失常性右心室心肌病 ）、房颤、 心脏通道病 （包括 长 QT 综合征 和 Brugada 综合征）
运动或情绪波动时出现心悸
运动或情绪波动时出现心悸
窦性心动过速（心脏对压力的正常反应），特别常见于健康人 运动所致血流量减少引起的异常心律，更常见于有冠状动脉疾病或先天性心脏病的患者
窦性心动过速（心脏对压力的正常反应），特别常见于健康人
运动所致血流量减少引起的异常心律，更常见于有冠状动脉疾病或先天性心脏病的患者
在有家族昏厥或猝死病史的人群中
在有家族昏厥或猝死病史的人群中
心脏通道病（包括 Brugada 综合征和先天性长 QT 综合征）或遗传性致心律失常性心肌病（包括扩张型或肥厚型心肌病）
心脏通道病（包括 Brugada 综合征和先天性长 QT 综合征）或遗传性致心律失常性心肌病（包括扩张型或肥厚型心肌病）
在发生出血、发热、疼痛或体液丢失（可由呕吐或腹泻引起）的人群中
在发生出血、发热、疼痛或体液丢失（可由呕吐或腹泻引起）的人群中
窦性心动过速
窦性心动过速
怕热、消瘦、眼球突起并有颈前部压痛和 / 或肿胀
怕热、消瘦、眼球突起并有颈前部压痛和 / 或肿胀
甲状腺功能亢进导致的窦性心动过速或心房纤维颤动
甲状腺功能亢进导致的窦性心动过速或心房纤维颤动
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
PSVT=阵发性室上性心动过速。
PSVT=阵发性室上性心动过速。
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
*医生始终会查体。特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

PSVT=阵发性室上性心动过速。
PSVT=阵发性室上性心动过速。
检查
尽管引起心悸的大多数原因并不是很严重，但通常还是需要做检测。
心电图检查（ECG），有时采用动态检测
心电图检查（ECG），有时采用动态检测
实验室检测
实验室检测
有时候进行影像学检查，负荷试验或者两者同时采用
有时候进行影像学检查，负荷试验或者两者同时采用
有时电生理学检查
有时电生理学检查
心电图 需要做。如果心电图检查恰好在患者心悸或异常脉搏发作期间完成，诊断结果一般是明确的。然而，由于患者在做心电图时可能没有出现心悸，因而描记出异常心电图只是少数的情况。因此，对于有间歇性心悸的患者可能需要佩戴心电监测仪一至两天（Holter 监测—参见图 Holter 监测仪 ）或是更长时间（事件记录仪），来检测短暂的或不规律的异常心脏节律。在有些人中，医生可能会在皮下植入一个装置来监测心搏。这种装置称为循环记录仪，它能持续监测患者的心搏。然后，医生可使用体外监护仪来检查循环记录仪是否记录到异常心律。一些市售产品（例如可监测心率的 Fitness Tracker 手环以及其他一些可监测并跟踪心律的追踪器）现已应用于智能手机和智能手表，但提供的信息更为有限。
实验室检查 是需要的。医生检查全血细胞计数和测定血清电解质含量，包括钾、镁和钙。如患者有提示 急性冠脉综合征 的其他症状，医生可能会检查血液中的其他物质含量（心脏生物标志物）。如果医生怀疑患者甲状腺功能亢进，会测定患者血中的甲状腺激素水平；对可能患有 嗜铬细胞瘤 的患者，医生会测定其他激素的水平。根据医生怀疑的其他病因，可能需要做另外一些检查。
有时需要做 影像学检查 。对于心电图检查结果提示心脏病的患者，医生会做 超声心动图 检查，有时也会进行心脏 磁共振成像（MRI）。对于活动时有症状的患者，需做 负荷试验 ，有时也需进行负荷超声心动图检查或核扫描。
当患者症状严重，医生怀疑有危险的心脏节律问题，但其他检查都未能发现时，医生会做 电生理（EP）检查 。在这项检查中，医生将一个很小的电极经静脉放入心脏。这个小电极能比心电图更详细地记录心脏的电活动。
对心悸的治疗
停用已知会加剧心悸的药物和物质（如 咖啡因 ）。如果危险或衰弱的心律失常由必要的治疗药物引起，医生应尝试更换一种其他药物。
通常情况下，医生仅能对非心脏病引起的房性或室性早搏患者提供保障。这些无害的心悸如果给患者带来很大困扰，医生有时会给予 β 受体阻断剂（一类抗心律失常药）。其他经确诊的 节律紊乱和基础疾病 需评估和治疗。医生经常首先给予节律控制药物（例如地高辛、氟卡尼、维拉帕米、地尔硫卓，或胺碘酮）。然而，这些药物中许多本身可以引起心律紊乱以及其他副作用。
对于某些心律失常（例如，心房扑动和 PSVT）来说， 射频消融 是一种更具侵入性的治疗方法，通常是最好的治疗选项。如果药物无效，或者患者存在某种危险的节律紊乱，医生可能会进一步使用侵入性治疗手段，如直流电心脏复律或植入起搏器和除颤器。治疗的选择取决于引起疾病的具体情况。
老年人须知：心悸
抗心律失常药对老年人群存在着特殊的副作用风险。老年人可能更容易同时存在几种健康问题而同时使用几种药物，这些药物联合使用会将老年人置于副作用风险中。老年人肾脏有效地从血液中过滤药物的能力较差，这也增加了副作用风险。有些老年人甚至在使用抗心律失常药物之前需要植入心脏起

搏器。
关键点
心悸的病因有很多，从无害的病因到威胁生命的病因都可以引起心悸。
心悸的病因有很多，从无害的病因到威胁生命的病因都可以引起心悸。
伴有其他症状的心悸，如头晕、胸痛或胸闷、或呼吸急促可能存在严重的疾患，应该尽快就医。
伴有其他症状的心悸，如头晕、胸痛或胸闷、或呼吸急促可能存在严重的疾患，应该尽快就医。
需做心电图和某些血液检查，并且通常来说还会做其他专门的心脏检查。
需做心电图和某些血液检查，并且通常来说还会做其他专门的心脏检查。
治疗取决于病因。
治疗取决于病因。